

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Cystoscopy & Retrograde Pyelogram (+/-) Insertion of Ureteric Stent

منظار المثانة البولية & التصوير العكسي للحوض والحالبين (+/-) إدخال دعامة في الحالب

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

A cystoscopy is where the doctor looks and examines the inside of the bladder and urethra using a fine telescopic-type instrument called a cystoscope. A catheter is passed from the bladder into the kidney followed by contrast media injections to show up the ureter and the kidney on x-ray.

If a blockage in the ureter is found, a stent (plastic tube) will be inserted into the ureter to keep it open. The stent is a double pigtail tube that sits in the ureter and is held in place at the kidney end and the bladder end by the pig tail shape of the tube.

C. Risks of a cystoscopy & retrograde pyelogram (+/-) insertion of ureteric stent

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضر ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و / أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :

منظار المثانة البولية هو إجراء يمكن من خلاله الطبيب من رؤية وفحص المثانة البولية والإحليل (قناة مجرى البول) من الداخل باستخدام أداة دقيقة من الأدوات المستخدمة في التقريب تسمى المنظار.
يتم تمرير قسطرة من المثانة البولية إلى الكلية ويتبع ذلك حقن صبغة لإظهار الحالب والكلية بالأشعة السينية.

إذا تم اكتشاف وجود انسداد في الحالب ، يتم إدخال دعامة (أنبوب بلاستيكي) إلى داخل الحالب لإبقائه مفتوحاً . الدعامة عبارة عن ضفيرة أنبوبية مزدوجة يتم وضعها في الحالب ، ويساعد شكلها الضفيري على تثبيتها في نهاية الكلية ونهاية المثانة البولية.

ج. مخاطر منظار المثانة البولية & التصوير العكسي للحوض والحالبين (+/-) إدخال دعامة في الحالب

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Allergic reaction to the contrast media used as part of the x-ray, which may need emergency treatment.
- Rarely damage to the urethra. A false passage may be produced causing leakage of urine or in the long term, a narrowing that may affect flow of urine.
- Damage to the bladder by puncturing the bladder wall. This may need further surgery.
- Swelling at the exit of the bladder which may stop passage of urine. A tube (catheter) may need to be inserted to drain the urine until the swelling goes down.
- Bacteria may get into the blood stream with the development of septicaemia. Further treatment with antibiotics may be necessary.
- The tube may pass outside the ureter into the tissues. This may need further surgery to remove and replace the tube.

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- رد فعل تحسسي لمادة الوسط المتباين المستخدمة كجزء من فحص الأشعة السينية. قد يتطلب ذلك معالجة طارئة.
- من النادر حدوث ضرر للإحليل (قناة مجرى البول). قد يتكون ممر خاطئ مما يتسبب في تسرب البول، أو على المدى البعيد قد يحدث ضيق يؤثر على جريان البول.
- ضرر للمثانة البولية بسبب إحداث ثقب في جدارها. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- تورم في مخرج المثانة البولية مما قد يمنع مرور البول. قد تكون هناك حاجة لإدخال أنبوب (قسطرة) لتصريف البول لحين تعافي التورم.
- قد تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم ويحدث تسمم (تجرثم) للدم. قد تكون هناك حاجة للعلاج بالمضادات الحيوية.
- قد يخرج الأنبوب من الحالب إلى الأنسجة. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى لإزالة واستبدال الأنبوب.
- حدوث نزيف قد يؤدي إلى تغيير لون البول وقد يعيق

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Bleeding which may stain the urine color and sometimes cause blockage of urine flow.
- Burning and scalding of urine for a few days after the procedure. This usually settles.
- The catheter may not be able to be passed through the ureteric opening and up to the kidney because of a blockage.
- The indwelling stent may cause bladder irritation and blood in the urine occasionally. The stent is usually removed after a few weeks or days.
- Rarely, damage to ureter. A stricture may form. Very rarely, an open operation may be required to repair the damage.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anesthetic. (Doctor to document type of anesthetic discussed)

أحياناً تدفق البول.

- حرارة و حرقان في البول لعدة أيام بعد الإجراء . عادةً ما يتعافى ذلك.
- قد لا يتمكن الطبيب من تمرير القسطرة عبر فتحة الحالب صعوداً إلى الكلية بسبب وجود انسداد.
- قد يسبب وجود وبقاء الدعامة في موقعها تهيج للمثانة البولية و خروج دم مع البول أحياناً. عادةً ما تتم إزالة الدعامة بعد عدة أسابيع أو أيام.
- من النادر حدوث ضرر للحالب . قد تنشأ منطقة تضيق . من النادر جداً أن تكون هناك حاجة للقيام بالفتح الجراحي من أجل إصلاح الضرر.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير . (يقوم الطبيب بالمعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient

Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anesthetic
- ☐ Cystoscopy & Retrograde Pyelogram (+/-) Insertion of Ureteric Stent
- ☐ Blood and Blood Products Transfusion

ز. إقرار المريض
أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقفاً . أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ منظار المثانة البولية & التصوير العكسي للحوض والحالبين (+/-) إدخال دعامة في الحالب

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:..... Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:.....

Relationship to patient:

Date:..... Time:.....

Contact No:.....

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:.....

Designation:

- نقل الدم ومشتقات الدم لي
- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ :

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك القدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ :

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Signature:

Date:.....Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

.....: التوقيع

.....: التاريخ

.....: الوقت

توقيع الشهود :

_____ : الاسم _____ : التاريخ _____ : (1)

_____ : التوقيع _____ : الوقت _____ :

_____ : الاسم _____ : التاريخ _____ : (2)

_____ : التوقيع _____ : الوقت _____ :